

Traumatisme du thorax

Face à une urgence ou une détresse vitale, ou en cas d'aggravation

- appliquer la conduite à tenir adaptée et réaliser en priorité les gestes d'urgence qui s'imposent ;
- ne jamais retirer un corps étranger pénétrant dans le thorax, sauf s'il empêche la réalisation d'une RCP ;

En l'absence de détresse vitale apparente

- appliquer la conduite à tenir face à une plaie grave ;
- adapter la conduite à tenir avec :
 - mettre la victime dans une position¹ assise ou demi-assise dès lors qu'il existe une gêne respiratoire ;
 - dénuder² le thorax de la victime :
 - vérifier la présence de lésions dans le dos de la victime,
 - particulièrement au cours de sa mobilisation³ ;
 - protéger la plaie par :
 - un dispositif médical non occlusif spécifique à cette utilisation s'il est à disposition,
 - en son absence, laisser la plaie à l'air libre⁴ ;
 - administrer de l'oxygène en inhalation, si nécessaire ;

¹ Cette position sera maintenue lors de son relevage et de son transport.

² Dans la mesure du possible cela doit se faire en préservant son intimité et si possible sans l'exposer au froid.

³ Installation en : position assise, position latérale de sécurité.

⁴ En l'espèce, le pansement non occlusif doit permettre la sortie de l'air piégé dans le thorax par la plaie et empêcher sa pénétration.